Recommandations SFORL 2017

AINS et infections ORL pédiatriques

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF
17 mai 2017

Introduction

- Seul objectif des AINS dans les infections ORL de l'enfant: traitement de la douleur (grade A).
- Infections ORL courantes non compliquées les plus douloureuses: OMA et angines (grade B).
- Rhinopharyngites et sinusites maxillaires généralement moins douloureuses et donc AINS moins fréquemment indiqués.
- La réduction de l'hyperthermie n'est pas une priorité thérapeutique (grade A).

Infections concernées

- Otites moyennes aiguës
- Otites externes aiguës
- Adénites aiguës latéro-cervicales ou rétro-pharyngées
- Pharyngites aiguës ; angines
- Rhinosinusites aiguës
- Infections dentaires et stomatologiques exclues

Indications des antalgiques et leur choix en fonction du niveau de douleur (1)

- Faible intensité (EVA <3 ou EVENDOL <4): ne rien prescrire ou paracétamol seul.
- Intensité moyenne (EVA 3 à 5 ou EVENDOL 4 à 7): paracétamol en première intention, et ajout ibuprofène* en cas d'échec (ordonnance évolutive).
- Intensité modérée à forte (EVA 5 à 7 ou EVENDOL 7 à10), ou résistance au paracétamol : AINS recommandés en association avec le paracétamol*

* Si prescription de paracétamol et ibuprofène:

  - Association à prendre toutes les 6 heures
  - Ou alternance toutes les 3 heures (chaque molécule prise toutes les 6 heures)

Indications des antalgiques et leur choix en fonction du niveau de douleur (2)

- Intensité forte à très forte (EVA > 7 ou EVENDOL > 10), ou résistance à paracétamol + ibuprofène : ajouter 1 ou 2 doses orales de morphinique (morphine orale, ou tramadol au-dessus de 3 ans).
- L'objectif est toujours d'obtenir un EVA < 3 ou EVENDOL < 4.
- Si OMA avec douleurs d'intensité forte à très forte, la paracentèse n'a pas d'intérêt à titre antalgique.

AINS et évolution de l’infection

Il n’existe aucune preuve d’une action des AINS sur :

- une diminution de la durée d’évolution de l’infection (Grade A)
- l’évolution d’une OMA vers une otite séro-muqueuse(OSM) (Grade B)

Contre-indications et limitations de prescription des AINS

- Varicelle en cours (risque accru d'infections invasives à streptocoque A beta hémolytique) (Grade C)

- Infection ORL bactérienne grave ou compliquée (mastoïdite aiguë extériorisée; abcès rétropharyngé, rétrostylien ou préstylien; cellulite faciale, cervicale ou cervico-médiastinale; sinusite non maxillaire), complications infectieuses diverses (labyrinthite, paralysie faciale, infection orbitaire ou intracrânienne, thrombophlébite septique, métastase septique, choc septique) (Accord professionnel) ;

- Existence d'une autre localisation infectieuse en particulier pleuro-pulmonaire, cutanée ou des tissus mous (Grade D).

Examens complémentaires préalables

Aucun examen complémentaire n’est nécessaire avant l’instauration d’un traitement par AINS chez un enfant souffrant d’une infection ORL (Accord professionnel).

Information de la famille

Les risques de complications sévères liées aux AINS sont réduits par une bonne information du patient ou de ses parents sur les risques de ce traitement et sur la conduite à tenir en cas de symptômes compatibles avec une telle complication (Accord professionnel).

Interruption du traitement

- Durée de l’infection ou symptomatologie inhabituelles, faisant craindre une complication
- Epigastralgies ou autres symptômes digestifs
- Rash cutané, lésions muqueuses ou toute autre manifestation d’hypersensibilité
- Signes d’aggravation ou apparition d’une cardiopathie
- Déshydratation.

Choix de molécules

- L’ibuprofène (AMM à partir de 3 mois) et le kétoprofène (AMM à partir de 6 mois) ont une présentation en sirop particulièrement adaptée à l’enfant (Grade B);
- Les données de la littérature en infectiologie pédiatrique concernent essentiellement l’ibuprofène
- Les suppositoires ne sont pas recommandés en dehors de difficultés d’administration orale (refus de l’enfant, dysphagie ou odynophagie majeures, vomissements) (Accord professionnel)

Durée du traitement par AINS

- Pour minimiser les risques d'effets secondaires des AINS, la durée de leur prescription doit être la plus courte possible
  - arrêt dès disparition de la douleur.
  - dans les 72h au maximum (au-delà de cette durée, la persistance de la douleur doit faire rechercher une complication et suspendre les AINS) (Accord professionnel).